内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·心脏骤停（内科+外科）

（性感认识：C→A→B）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、心脏性猝死

1.原因

①最常见：**冠心病**及其并发症

②＜35 岁：**肥厚型梗阻性心肌病（最常见）**、致心律失常性右室心肌病、离子通道病（如长 QT 间期综合征、Brugada 综合征）胖胖又买 QB

2.心脏骤停时**室颤最常见**。**无脉性室速**可在短时间内迅速恶化为室颤、可以和室颤同等对待 也需要进行电除颤



二、心肺脑复苏（心脏骤停抢救成功的关键）

1.**胸外按压**（circulation,**C**）→**开通气道**（airway,**A**）→**人工呼吸**（breathing,**B**）

①按压部位：胸骨下 1/2、剑突上 4-5cm（双乳头连线中点）

②按压幅度：**5-6**cm

③按压频率：**100-120** 次/分

④通气频率：10 次/分

⑤按压与放松时间比：1:1

⑥按压与通气比：**30:2**

⑦头后仰、抬起下颏以防止舌后坠，捏闭 ttsx 鼻孔

⑧**无**需深吸气，吹气持续＞1s 以确保胸廓起伏

容易导致气道压力过高

2.电除颤首次能量：**单相波 360J**、双相波 120-200J

3.**静脉**注射**肾上腺素** 强心

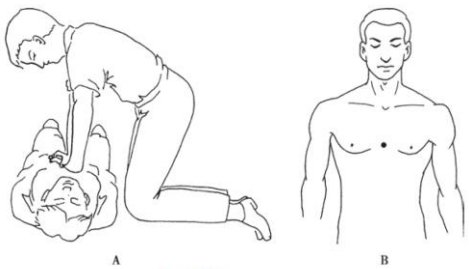


图 3-11-1　胸外按压

A. 操作者肩部正对病人胸骨上方，肘部保持不动；B. 先确定按压部位，然后正确摆放手的位置。

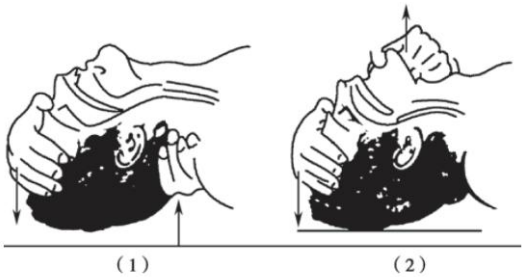


图 17-2　仰头抬颏法

（1）头后仰　（2）提起下颌



图 3-11-2　口对口人工呼吸